

« effacés » au fur et à mesure que la maladie progresse. De telles pertes de mémoire ne sont pas en rapport avec des traumatismes et semblent apparaître au hasard. Des électroencéphalogrammes répétés montrent habituellement des anomalies. Un monitoring électroencéphalographique télémétrique montre en général une association entre les épisodes d'amnésie et l'activité convulsive. Des amnésies dissociatives et épileptiques peuvent s'associer.

Stupeur catatonique. Le mutisme de la stupeur catatonique peut évoquer une amnésie dissociative mais il n'y a pas d'altération du rappel mnésique. D'autres symptômes de la catatonie (rigidité, position affectée, négativisme) sont habituellement présents.

Troubles factices et simulation. Il n'existe aucun procédé, test ou batterie de tests permettant de distinguer l'amnésie dissociative d'une amnésie feinte (Bourget et Whitehurst 2007 ; Bronks 1987 ; Schacter 1986). Il a été noté que les sujets ayant un trouble factice ou pratiquant la simulation peuvent poursuivre leur tromperie même lors d'entretiens sous hypnose ou barbituriques (Ruedrich et al. 1985). L'amnésie feinte est plus fréquente chez les personnes 1) qui présentent une amnésie dissociative aiguë, spectaculaire, 2) ayant des problèmes financiers, sexuels ou judiciaires, ou 3) qui veulent échapper à des circonstances stressantes. Une amnésie vraie peut être associée aux mêmes circonstances. De nombreux sujets qui simulent finissent par le reconnaître spontanément ou bien lorsqu'ils sont confrontés à des preuves (Kopelman 1987 ; Parwatikar et al. 1985 ; Schacter 1986).

Modifications de la mémoire normales et liées à l'âge. Les affaiblissements mnésiques des troubles neurocognitifs majeurs et légers sont différents de ceux de l'amnésie dissociative, qui sont en général associés à des événements stressants, plus spécifiques, étendus et/ou complexes.

Comorbidité

Lorsque l'amnésie dissociative connaît une rémission, une grande variété de phénomènes affectifs peut remonter à la surface : dysphorie, chagrin, rage, honte, culpabilité, conflit et bouleversement psychologique, idées, impulsions et actes suicidaires et homicides. Ces sujets peuvent présenter des symptômes qui répondent aux critères du trouble dépressif persistant (dysthymie), du trouble dépressif caractérisé, d'un autre trouble dépressif spécifié ou non spécifié, d'un trouble de l'adaptation avec humeur dépressive ou d'un trouble de l'adaptation avec perturbations à la fois des émotions et des conduites. De nombreux individus ayant une amnésie dissociative présentent un trouble stress post-traumatique à un certain moment de leur vie, en particulier lorsque les antécédents traumatiques de l'amnésie reviennent à la conscience.

De nombreux sujets ayant une amnésie dissociative présentent des symptômes qui répondent aux critères diagnostiques d'un trouble à symptomatologie somatique et apparenté comorbide (et vice versa), dont le trouble à symptomatologie somatique et le trouble de conversion (trouble à symptomatologie neurologique fonctionnelle). De nombreux individus ayant une amnésie dissociative répondent aux critères diagnostiques d'un trouble de la personnalité en particulier dépendante, évitante et borderline (Coons et Millstein 1992).

Dépersonnalisation/déréalisation

Critères diagnostiques

300.6 (F48.1)

A. Expériences prolongées ou récurrentes de dépersonnalisation, de déréalisation, ou bien des deux :

1. **Dépersonnalisation** : Expériences d'irréalité, de détachement, ou bien d'être un observateur extérieur de ses propres pensées, de ses sentiments, de ses sensations,

de son corps ou de ses actes (p. ex. altérations perceptives, déformation de la perception du temps, impression d'un soi irréel ou absent, indifférence émotionnelle et/ou engourdissement physique).

2. **Déréalisation** : Expériences d'irréalité ou de détachement du monde extérieur (p. ex. les personnes ou les objets sont ressentis comme étant irréels, perçus comme dans un rêve, dans un brouillard, sans vie ou bien visuellement déformés).
 - B. Pendant les expériences de dépersonnalisation ou de déréalisation, l'appréciation de la réalité demeure intacte.
 - C. Les symptômes sont à l'origine d'une détresse cliniquement significative ou d'une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.
 - D. La perturbation n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance (p. ex. une drogue donnant lieu à un abus, un médicament) ou à une autre affection médicale (p. ex. des crises comitiales).
 - E. La perturbation n'est pas mieux expliquée par un autre trouble mental, comme une schizophrénie, un trouble panique, un trouble dépressif caractérisé, un trouble stress aigu, un trouble stress post-traumatique ou un autre trouble dissociatif.
-

Caractéristiques diagnostiques

Les caractéristiques essentielles de la dépersonnalisation/déréalisation sont des épisodes persistants ou récurrents de dépersonnalisation, de déréalisation ou de dépersonnalisation et de déréalisation (Spiegel et al. 2011). Les épisodes de dépersonnalisation sont caractérisés par un sentiment d'irréalité ou de détachement ou par une absence de familiarité par rapport à l'ensemble de sa propre personne ou à certains aspects de sa personne (critère A1). Le sujet peut se sentir détaché de son moi entier (p. ex. « Je ne suis personne », « Je n'ai pas de moi »). Il peut aussi se sentir détaché subjectivement de certains aspects de son moi, notamment de ses sentiments (p. ex. réduction des émotions : « Je sais que j'ai des sentiments mais je ne les ressens pas »), de ses pensées (p. ex. « C'est comme si mes pensées n'étaient pas vraiment les miennes », « J'ai la tête remplie de coton »), de son corps entier ou certaines parties du corps, ou de ses sensations (p. ex. le toucher, la proprioception, la faim, la soif, la libido). Il peut y avoir une diminution de l'agentivité (p. ex. se sentir comme un robot, comme un automate, manquer de contrôle sur ce que l'on dit ou sur ses mouvements). La dépersonnalisation peut être l'expérience d'un moi coupé en deux, l'une des parties observant et l'autre agissant, connue comme « l'expérience d'être en dehors de son corps » dans sa forme extrême. Le symptôme unitaire de « dépersonnalisation » est fait de plusieurs facteurs symptomatiques (Sierra et al. 2005 ; Simeon et al. 2008) : expériences anormales par rapport au corps (c.-à-d. irréalité du moi et altérations perceptives), indifférence émotionnelle ou engourdissement physique, distorsions du rapport au temps avec des anomalies du rappel subjectif.

Les épisodes de déréalisation sont caractérisés par un sentiment d'irréalité ou de détachement, ou par une absence de familiarité par rapport au monde, qu'il s'agisse des personnes, des objets inanimés ou de tout environnement (critère A2). Le sujet peut avoir l'impression qu'il est dans le brouillard, dans un rêve, dans une bulle, ou qu'il y a un voile ou un écran de verre entre lui et le monde extérieur. L'environnement peut être ressenti comme artificiel, sans couleur ou sans vie. La déréalisation est souvent accompagnée de distorsions visuelles subjectives, comme une vue trouble, une acuité visuelle augmentée, un champ visuel élargi ou rétréci, une vision à deux dimensions ou bien aplatie, une exagération de la vision à trois dimensions, une altération de la distance aux objets ou de leur taille (c.-à-d. une macropsie ou une micropsie). Des distorsions auditives peuvent aussi survenir, les voix étant assourdies ou bien trop sonores. De plus, le critère C requiert la présence d'une détresse cliniquement significative ou

d'une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants, et les critères C et D décrivent les diagnostics différentiels.

Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

Les sujets ayant une dépersonnalisation/déréalisation peuvent éprouver des difficultés à décrire leurs symptômes et croire qu'ils sont « fous » ou « en train de devenir fous » (Baker et al. 2003 ; Simeon et al. 2003). Une autre expérience fréquente est la crainte d'un dommage cérébral irréversible (Simeon et al. 2009). Une altération subjective du sens du temps est un symptôme souvent associé (c.-à-d. l'impression qu'il est accéléré ou ralenti), de même qu'une difficulté subjective à se rappeler nettement de souvenirs passés et à les ressentir comme vraiment personnels, avec leur charge émotionnelle (Baker et al. 2003 ; Simeon et al. 2003). De vagues symptômes somatiques, comme la tête pleine, des picotements ou des étourdissements ne sont pas rares. Les sujets peuvent souffrir d'extrêmes ruminations ou préoccupations obsessionnelles (p. ex. être obsédés constamment par la question de savoir s'ils existent réellement, ou vérifier leurs perceptions pour déterminer si elles semblent réelles). Des degrés variables d'anxiété et de dépression sont aussi des caractéristiques fréquemment associées. On a constaté une diminution de la réactivité physiologique aux stimuli émotionnels chez les personnes qui ont ce trouble (Sierra et al. 2002). Les substrats neuronaux en cours d'exploration sont l'axe hypothalamo-hypophyso-adrénocortical, le lobule pariétal inférieur et les circuits cortico-limbiques préfrontaux (Lemche et al. 2007 ; Phillips et al. 2001 ; Simeon et al. 2000 ; Simeon et al. 2007).

Prévalence

Des épisodes de dépersonnalisation/déréalisation transitoires, durant quelques heures à quelques jours, sont fréquents dans la population générale. On pense que la prévalence sur 12 mois de la dépersonnalisation/déréalisation est nettement inférieure à celle des symptômes transitoires, bien que l'on ne dispose pas d'estimations précises pour ce trouble (Aderibigbe et al. 2001). Approximativement la moitié de tous les adultes ont au cours de leur vie au moins une expérience de dépersonnalisation/déréalisation. Toutefois, le tableau symptomatique répondant à la totalité des critères diagnostiques de la dépersonnalisation/déréalisation est nettement moins fréquent que les symptômes transitoires. La prévalence sur la vie aux États-Unis et dans les autres pays est approximativement de 2 % (entre 0,8 et 2,8 %) (Hunter et al. 2004). Le ratio selon le sexe pour ce trouble est de 1/1.

Développement et évolution

L'âge de début moyen de la dépersonnalisation/déréalisation est 16 ans, bien que le trouble puisse commencer dès la petite enfance ; une minorité de sujets n'a pas le souvenir d'avoir connu une période où ils n'avaient pas les symptômes. Le début se situe après 20 ans chez moins de 20 % des individus, et après 25 ans chez seulement 5 %. Un début après 40 ans ou plus tard est très inhabituel. Le mode de début connaît tous les degrés, de très brutal à progressif. La durée des épisodes de dépersonnalisation/déréalisation peut beaucoup varier, de brève (quelques heures à quelques jours) à prolongée (des semaines, des mois ou des années). Étant donnée la rareté des débuts après 40 ans, il faut rechercher une affection médicale sous-jacente (p. ex. lésion cérébrale, convulsions, apnée du sommeil). L'évolution du trouble est souvent persistante. Environ un tiers des cas comporte des épisodes discrets, un autre tiers des symptômes continus depuis le début, et encore un autre tiers une évolution d'abord épisodique qui devient finalement continue.

Alors que chez certains sujets l'intensité des symptômes peut augmenter et diminuer considérablement, d'autres rapportent un niveau d'intensité qui ne faiblit pas et qui

dans des cas extrêmes est constant pendant des années ou des décennies. Les facteurs internes et externes qui modifient l'intensité des symptômes varient selon les individus ; cependant il existe certains schémas typiques. L'aggravation peut être provoquée par le stress, une accentuation de symptômes thymiques et anxieux, un environnement nouveau ou trop stimulant et des facteurs physiques comme la luminosité ou le manque de sommeil.

Facteurs de risque et pronostiques

Tempéramentaux. Les sujets ayant une dépersonnalisation/déréalisation sont caractérisés par un tempérament d'évitement de la douleur, des défenses immatures et des *schémas* à la fois de déconnexion et de surconnexion (Simeon et al. 2002). Les défenses immatures comme l'idéalisation/dévalorisation, la projection et le passage à l'acte sont à l'origine d'un déni de la réalité et d'une mauvaise adaptation. Les schémas de déconnexion cognitive reflètent la déficience et l'inhibition émotionnelle et subsument des thèmes d'abus, de manquement et de carence. Les schémas de surconnexion impliquent une perte d'autonomie avec des thèmes de dépendance, de vulnérabilité et d'incompétence.

Environnementaux. Chez de nombreux sujets, il existe une association claire entre le trouble et des traumatismes interpersonnels au cours de l'enfance (Spiegel et al. 2011), bien que cette association ne soit pas aussi fréquente ou aussi extrême en ce qui concerne la nature des traumatismes que dans les autres troubles dissociatifs, comme le trouble dissociatif de l'identité. En particulier, ce sont l'abus et la négligence émotionnels qui ont été le plus fortement et invariablement associés au trouble (Simeon et al. 2001 ; Simeon et al. 2007). D'autres facteurs de stress peuvent être l'abus physique, le fait d'être témoin de violences domestiques, de grandir avec un parent gravement handicapé, malade mental, ou la mort ou le suicide inattendu d'un membre de la famille ou d'un ami proche. L'abus sexuel est un antécédent beaucoup moins fréquent mais il est possible. Les facteurs précipitants immédiats les plus fréquents sont un stress grave (interpersonnel, financier, professionnel), la dépression, l'anxiété (particulièrement les attaques de panique) et l'usage de drogues illicites (Simeon et al. 2003 ; Simeon et al. 2009). Les symptômes peuvent être spécifiquement induits par des substances telles que le tétrahydrocannabinol, des hallucinogènes, la kétamine, le MDMA (3,4-méthylènedioxymétamphétamine ; « ecstasy ») et la salvia² (Medford et al. 2003 ; Simeon et al. 2009). L'usage de la marijuana peut précipiter simultanément l'apparition d'attaques de panique et de symptômes de dépersonnalisation/déréalisation.

Questions diagnostiques liées à la culture

Des expériences de dépersonnalisation/déréalisation induites volontairement peuvent faire partie de pratiques méditatives répandues dans certaines religions et cultures et ne doivent pas être diagnostiquées comme un trouble. Cependant, certains sujets provoquent d'abord ces états intentionnellement puis perdent le contrôle avec le temps et développent une peur et une aversion pour ce genre de pratiques.

Retentissement fonctionnel de la dépersonnalisation/déréalisation

Les symptômes de la dépersonnalisation/déréalisation sont extrêmement pénibles et ils sont associés à une morbidité importante (Baker et al. 2003 ; Simeon et al. 2003). Le comportement robotisé avec un émoussement émotionnel, fréquent chez ces sujets,

2. NDT : *Salvia divinorum*, une espèce de sauge hallucinogène.

peut contraster avec la souffrance émotionnelle extrême dont ils font part. Autant le fonctionnement interpersonnel que professionnel est souvent altéré, largement à cause de la diminution des émotions dans les relations avec les autres, de la difficulté subjective à se concentrer sur l'information et à la garder en mémoire et à une impression générale de déconnexion d'avec la vie.

Diagnostic différentiel

Crainte excessive d'avoir une maladie. Bien que les sujets ayant une dépersonnalisation/déréalisation puissent présenter de vagues plaintes somatiques et exprimer la peur d'avoir des lésions cérébrales durables, le diagnostic de dépersonnalisation/déréalisation suppose la présence d'une constellation de symptômes de dépersonnalisation/déréalisation typiques et l'absence d'autres manifestations de la crainte excessive d'avoir une maladie.

Trouble dépressif caractérisé. Des sentiments d'indifférence, de mort, d'apathie et de vivre dans un rêve ne sont pas rares dans les épisodes dépressifs caractérisés. Toutefois, dans la dépersonnalisation/déréalisation, de tels symptômes sont associés à d'autres symptômes du trouble. Si la dépersonnalisation/déréalisation précède clairement le début d'un épisode dépressif caractérisé, ou continue clairement après qu'il se soit résolu, il convient de porter le diagnostic de dépersonnalisation/déréalisation.

Trouble obsessionnel-compulsif. Certains sujets ayant une dépersonnalisation/déréalisation en viennent à être préoccupés de manière obsessionnelle par l'expérience subjective qu'ils vivent ou bien développent des rituels de vérification quant à l'état de leurs symptômes. Cependant, il n'y a pas d'autres symptômes du trouble obsessionnel-compulsif non liés à la dépersonnalisation/déréalisation.

Autres troubles dissociatifs. Pour porter le diagnostic de dépersonnalisation/déréalisation, il faut que les symptômes ne surviennent pas dans le contexte d'un autre trouble dissociatif, comme le trouble dissociatif de l'identité. Le diagnostic différentiel par rapport à l'amnésie dissociative et au trouble de conversion (trouble à symptomatologie neurologique fonctionnelle) est plus simple, dans la mesure où les symptômes de ces troubles ne sont pas les mêmes que ceux de la dépersonnalisation/déréalisation (Spiegel et al. 2011).

Troubles anxieux. La dépersonnalisation/déréalisation est l'un des symptômes des attaques de panique, d'autant plus fréquent que l'intensité de l'attaque de panique augmente. De ce fait, il ne faut pas porter le diagnostic de dépersonnalisation/déréalisation lorsque les symptômes surviennent seulement pendant des attaques de panique, dans le cadre d'un trouble panique, d'une anxiété sociale ou d'une phobie spécifique. De plus, il n'est pas rare que des symptômes de dépersonnalisation/déréalisation se manifestent d'abord à l'occasion de l'apparition d'attaques de panique, ou lorsqu'un trouble panique progresse et s'aggrave. Dans de tels cas, le diagnostic de dépersonnalisation/déréalisation peut être posé si 1) la dépersonnalisation/déréalisation est une composante très importante du tableau clinique depuis le début, qui dépasse clairement en durée et en intensité les attaques de panique elles-mêmes, ou si 2) la dépersonnalisation/déréalisation continue après la rémission du trouble panique ou après que celui-ci ait été traité avec succès.

Troubles psychotiques. Une appréciation intacte de la réalité en ce qui concerne spécifiquement les symptômes de dépersonnalisation/déréalisation est essentielle pour faire le diagnostic différentiel entre la dépersonnalisation/déréalisation et les troubles psychotiques. Il est rare qu'une schizophrénie à symptômes positifs pose un problème diagnostique du fait d'idées délirantes de type « nihiliste ». Ainsi, une personne peut déclarer

qu'elle est morte ou que le monde n'est pas réel ; cela peut être soit une expérience subjective dont le sujet sait qu'elle ne correspond pas à la réalité, soit une conviction délirante.

Troubles induits par une substance/un médicament. On ne porte pas le diagnostic de dépersonnalisation/déréalisation lorsque la dépersonnalisation/déréalisation est associée aux effets physiologiques de substances durant une intoxication aiguë ou bien durant un sevrage. Les substances qui sont le plus souvent en cause sont les drogues suivantes : marijuana, hallucinogènes, kétamine, ecstasy et salvia (Simeon et al. 2009). Dans environ 15 % de tous les cas de dépersonnalisation/déréalisation, la survenue des symptômes est précipitée par la consommation de ces substances. Si les symptômes persistent un certain temps en l'absence de prise de substance ou de médicament, le diagnostic de dépersonnalisation/déréalisation peut s'appliquer. Ce diagnostic est habituellement facile à établir dans la mesure où une grande majorité des sujets qui présentent ce tableau clinique deviennent hautement phobiques et développent une grande aversion pour la substance qui déclenche les symptômes et ne la consomment plus (Simeon et al. 2009).

Trouble mental dû à une autre affection médicale. Des caractéristiques telles qu'un début après 40 ans, la présence de symptômes ou une évolution atypiques chez n'importe quel sujet suggèrent la possibilité d'une affection médicale sous-jacente. Dans de tels cas, il est essentiel de pratiquer un examen médical et neurologique approfondi, comportant notamment des recherches biologiques standard, des titrations virales, un électroencéphalogramme, un examen vestibulaire, visuel, du sommeil et/ou une imagerie cérébrale. Pour confirmer d'éventuelles convulsions sous-jacentes, il peut être utile de réaliser un électroencéphalogramme en ambulatoire ; bien qu'il s'agisse le plus souvent d'une épilepsie du lobe temporal, une épilepsie du lobe pariétal et frontal peut également être associée (Lambert et al. 2002).

Comorbidité

Dans un échantillon tout venant d'adultes ayant été recrutés pour différentes recherches sur la dépersonnalisation, la fréquence de la comorbidité sur la vie avec le trouble dépressif unipolaire et avec tous les troubles anxieux est élevée, une proportion significative de l'échantillon ayant les deux troubles. La comorbidité avec le trouble stress post-traumatique est rare. Les trois troubles de la personnalité les plus fréquemment associés sont la personnalité évitante, borderline et obsessionnelle-compulsive (Simeon et al. 2003).

Autre trouble dissociatif spécifié

300.15 (F44.89)

Cette catégorie s'applique aux tableaux cliniques où prédominent des symptômes caractéristiques d'un trouble dissociatif, entraînant une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants, sans toutefois remplir complètement les critères de l'un des troubles du chapitre des troubles dissociatifs. La catégorie « autre trouble dissociatif spécifié » est utilisée dans des situations où le clinicien choisit de communiquer la raison particulière pour laquelle le tableau clinique ne remplit les critères d'aucun trouble spécifique de ce chapitre. Cela se fait en enregistrant « autre trouble dissociatif spécifié » suivi de la raison particulière (p. ex. « transe dissociative »).

Des exemples de tableaux cliniques qui peuvent être qualifiés par la désignation « autre trouble spécifié » sont les suivants :

1. **Syndromes chroniques et récurrents de symptômes dissociatifs mixtes** : Cette catégorie inclut des perturbations de l'identité associées à des failles non graves dans le sens du soi et de l'agentivité, ou à des altérations de l'identité ou à des épisodes de possession chez une personne qui ne rapporte pas une amnésie dissociative.
2. **Perturbations de l'identité dues à des environnements de persuasion coercitive intense et prolongée** : Les personnes qui ont été soumises à des environnements de persuasion coercitive intense (p. ex. lavage de cerveau, rééducation idéologique, endoctrinement chez des prisonniers, torture, emprisonnement politique prolongé) peuvent présenter des modifications durables ou des questionnements conscients concernant leur identité.
3. **Réactions dissociatives aiguës à des événements stressants** : Cette catégorie s'adresse à des situations aiguës et transitoires qui durent typiquement moins d'un mois, et parfois seulement quelques heures ou quelques jours. Ces situations sont caractérisées par une restriction du champ de conscience, de la dépersonnalisation, de la déréalisation, des perturbations des perceptions (p. ex. ralentissement du temps, macropsie), des micro-amnésies, une stupeur transitoire et/ou des altérations du fonctionnement sensori-moteur (p. ex. analgésie, paralysie).
4. **Transe dissociative** : Cette situation est caractérisée par une restriction aiguë ou une perte complète de la conscience de son environnement immédiat, ce qui se manifeste par un manque profond de réactivité ou une insensibilité aux stimuli environnementaux. Ce manque de réactivité peut être accompagné par des comportements stéréotypés mineurs (p. ex. mouvements des doigts) dont la personne n'est pas consciente ou qu'elle ne peut pas contrôler, ainsi que par des paralysies ou une perte de connaissance transitoire. La transe dissociative ne fait pas partie des pratiques religieuses ou culturelles collectives généralement admises.

Trouble dissociatif non spécifié

300.15 (F44.9)

Cette catégorie s'applique aux tableaux cliniques où prédominent des symptômes caractéristiques d'un trouble dissociatif, entraînant une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants, sans toutefois remplir complètement les critères de l'un des troubles du chapitre des troubles dissociatifs. La catégorie « trouble dissociatif non spécifié » est utilisée dans des situations où le clinicien choisit de *ne pas* spécifier la raison particulière pour laquelle les critères d'aucun trouble dissociatif spécifique ne sont remplis, et inclut des tableaux cliniques où l'information est insuffisante pour porter un diagnostic plus spécifique (p. ex. aux urgences).

Références

Trouble dissociatif de l'identité

- Brand BL, Armstrong JG, Loewenstein RJ: Psychological assessment of patients with dissociative identity disorder. *Psychiatr Clin North Am* 29(1):145–168, 2006a 16530591
- Brand BL, McNary SW, Loewenstein RJ, et al: Assessment of genuine and simulated dissociative identity disorder symptoms on the structured interview of reported symptoms. *J Trauma Dissociation* 7(1):63–85, 2006b 16618696

- Brand BL, Classen CC, McNary SW, Zaveri P: A review of dissociative disorders treatment studies. *J Nerv Ment Dis* 197(9):646–654, 2009 19752643
- Carlson EB, Putnam FW, Ross CA, et al: Validity of the Dissociative Experiences Scale in screening for multiple personality disorder: a multicenter study. *Am J Psychiatry* 150(7):1030–1036, 1993 8317572
- Dalenberg CJ, Brand BL, Gleaves DH, et al: Evaluation of the evidence for the trauma and fantasy models of dissociation. *Psychol Bull* 138(3):550–588, 2012 22409505
- Dell PF: A new model of dissociative identity disorder. *Psychiatric Clin North Am* 29(1):1–26, 2006 16530584
- Dell PF: The phenomena of pathological dissociation, in *Dissociation, the Dissociative Disorders, DSM-V, Beyond*, Edited by Dell, P.F., O'Neil, J.A., New York, Routledge, 2009, 225–238
- Dorahy MJ, Shannon C, Seagar L, et al: Auditory hallucinations in dissociative identity disorder and schizophrenia with and without a childhood trauma history: similarities and differences. *J Nerv Ment Dis* 197(12):892–898, 2009 20010024
- Draijer N, Boon S: The imitation of dissociative identity disorder: patients at risk, therapists at risk. *J Psychiatry Law* 27(3-4):423–458, 1999
- Ehling T, Nijenhuis ER, Krikke AP: Volume of discrete brain structures in complex dissociative disorders: preliminary findings. *Prog. Brain Res* 167:307–310, 2008 18037031
- Ellason JW, Ross CA, Fuchs DL: Lifetime Axis I and II comorbidity and childhood trauma history in dissociative identity disorder. *Psychiatry* 59(3):255–266, 1996 8912944
- Foote B, Smolin Y, Neft DI, Lipschitz D: Dissociative disorders and suicidality in psychiatric outpatients. *J Nerv Ment Dis* 196(1):29–36, 2008 18195639
- Goodwin JM: Munchausen's syndrome as a dissociative disorder. *Dissociation* 1:54–60, 1988
- Johnson JG, Cohen P, Kasen S, Brook JS: Dissociative disorders among adults in the community, impaired functioning, and axis I and II comorbidity. *J Psychiatr Res* 40(2):131–140, 2006 16337235
- Kluft RP (ed): *Childhood Antecedents of Multiple Personality*, Washington, DC, American Psychiatric Press, 1985
- Kluft RP: Clinical presentations of multiple personality disorder. *Psychiatr Clin North Am* 14(3):605–629, 1991 1946026
- Laddis A, Dell PF: Dissociation and psychosis in dissociative identity disorder and schizophrenia. *J Trauma Dissociation* 13(4):397–413, 2012 22651674
- Lewis DO, Yeager CA, Swica Y, et al: Objective documentation of child abuse and dissociation in 12 murderers with dissociative identity disorder. *Am J Psychiatry* 154(12):1703–1710, 1997 9396949
- Loewenstein RJ: Diagnosis, epidemiology, clinical course, treatment, and cost effectiveness of treatment for dissociative disorders and multiple personality disorder: report submitted to the Clinton administration task force on health care financing reform. *Dissociation* 7(1):3–11, 1994
- Loewenstein RJ, Putnam FW: A comparison study of dissociative symptoms in patients with complex partial seizures, MPD, and PTSD. *Dissociation* 1:17–23, 1988
- Loewenstein RJ, Putnam FW: The dissociative disorders, in *Comprehensive Textbook of Psychiatry VIII, 8th Edition*. Edited by Sadock BJ, Sadock VA. Baltimore, MD, Williams & Wilkins, 2004, 1844–1901
- Maercker A, Schützwohl M: Long-term effects of political imprisonment: a group comparison study. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol* 32(8):435–442, 1997 9409158
- Putnam FW: *Dissociation in Children and Adolescents: A Developmental Model*, New York, Guilford, 1997
- Putnam FW, Guroff JJ, Silberman EK, et al: The clinical phenomenology of multiple personality disorder: review of 100 recent cases. *J Clin Psychiatry* 47(6):285–293, 1986 3711025
- Ross CA, Ness L: Symptom patterns in dissociative identity disorder patients and the general population. *J Trauma Dissociation* 11(4):458–468, 2010 20938869
- Ross CA, Heber S, Anderson G, et al: Differentiating multiple personality disorder and complex partial seizures. *Gen Hosp Psychiatry* 11(1):54–58, 1989 2912820
- Ross CA, Miller SD, Reagor P, et al: Structured interview data on 102 cases of multiple personality disorder from four centers. *Am J Psychiatry* 147(5):596–601, 1990 2183634
- Sar V, Tutkun H, Alyanak B, et al: Frequency of dissociative disorders among psychiatric outpatients in Turkey. *Compr Psychiatry* 41(3):216–222, 2000 10834631
- Saxena S, Prasad KV: DSM-III subclassification of dissociative disorders applied to psychiatric outpatients in India. *Am J Psychiatry* 146(2):261–262, 1989 2912272
- Silberg J: *The Dissociative Child*, Lutherville, MD, Sidran Press, 1996

- Simeone D, Loewenstein RJ: Dissociative disorders, in *Comprehensive Textbook of Psychiatry*, 9th Edition, Vol 1. Edited by Sadock BJ, Sadock A, Ruiz P. Philadelphia, PA, Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2009, pp 1965–2026
- Spiegel D, Loewenstein RJ, Lewis-Fernández R, et al: Dissociative disorders in DSM-5. *Depress Anxiety* 28(9):824–852, 2011 10.1002/da.20874 21910187
- Tezcan E, Atmaca M, Kuloglu M, et al: Dissociative disorders in Turkish inpatients with conversion disorder. *Compr Psychiatry* 44(4):324–330, 2003 12923711
- Vermetten E, Schmahl C, Lindner S, et al: Hippocampal and amygdalar volumes in dissociative identity disorder. *Am J Psychiatry* 163(4):630–636, 2006 16585437

Amnésie dissociative

- Becker-Blease KA, Deater-Deckard K, Eley T, et al: A genetic analysis of individual differences in dissociative behaviors in childhood and adolescence. *J Child Psychol Psychiatry* 45(3):522–532, 2004 15055371
- Boon S, Draijer N: Multiple personality disorder in The Netherlands: a clinical investigation of 71 patients. *Am J Psychiatry* 150(3):489–494, 1993 8434668
- Bourget D, Whitehurst L: Amnesia and crime. *J Am Acad Psychiatry Law* 35(4):469–480, 2007 18086739
- Bronks IG: Amnesia: organic and psychogenic. *Br J Psychiatry* 151:414–415, 1987 3427302
- Coons PM, Millstein V: Psychogenic amnesia: a clinical investigation of 25 cases. *Dissociation* 5(2):73–79, 1992
- Courtois CA, Ford JD (eds): *Treating Complex Traumatic Stress Disorders: An Evidence-Based Guide*, New York, 2009, Guilford
- Dalenberg CJ: Recovered memory and the Daubert criteria: . recovered memory as professionally tested, peer reviewed, and accepted in the relevant scientific community. *Trauma Violence Abuse* 7:274–310, 2006
- Dalenberg CJ, Brand BL, Gleaves DH, et al: Evaluation of the evidence for the trauma and fantasy models of dissociation. *Psychol Bull* 138(3):550–588, 2012 22409505
- Edwards VJR, Fivush R, Anda RF, et al: Autobiographical memory disturbances in childhood abuse survivors, in *Trauma and Cognitive Science: A Meeting of Minds, Science, and Human Experience*. Edited by Freyd JJ, DePrince AP. Binghamton, NY, Howarth, 2001
- Gudjonsson GH, Haward LR: Case report—hysterical amnesia as an alternative to suicide. *Med Sci Law* 22(1):68–72, 1982 7062818
- Jang KL, Paris J, Zweig-Frank H, Livesley WJ: Twin study of dissociative experience. *J Nerv Ment Dis* 186(6):345–351, 1998 9653418
- Johnson JG, Cohen P, Kasen S, Brook JS: Dissociative disorders among adults in the community, impaired functioning, and axis I and II comorbidity. *J Psychiatr Res* 40(2):131–140, 2006 16337235
- Kasznik AW, Nussbaum PD, Berren MR, Santiago J: Amnesia as a consequence of male rape: a case report. *J Abnorm Psychol* 97(1):100–104, 1988 3351105
- Kikuchi H, Fujii T, Abe N, et al: Memory repression: brain mechanisms underlying dissociative amnesia. *J Cogn Neurosci* 22(3):602–613, 2010 19301997
- Kopelman MD: Amnesia: organic and psychogenic. *Br J Psychiatry* 150:428–442, 1987 3311268
- Kritchevsky M, Chang J, Squire LR: Functional amnesia: clinical description and neuropsychological profile of 10 cases. *Learn Mem* 11(2):213–226, 2004 15054137
- Lanius R, Brand B, et al: The dissociative subtype of posttraumatic stress disorder: rationale, clinical and neurobiological evidence and implications. *Depress Anxiety* 29(8):701–708, 2012 22431063
- Lochner C, Seedat S, Hemmings SM, et al: Investigating the possible effects of trauma experiences and 5-HTT on the dissociative experiences of patients with OCD using path analysis and multiple regression. *Neuropsychobiology* 56(1):6–13, 2007 17943026
- Loewenstein RJ: Psychogenic amnesia and psychogenic fugue: a comprehensive review, in *The American Psychiatric Press Annual Review of Psychiatry*, Vol 10. Edited by Tasman A, Goldfinger SM. Washington, DC, American Psychiatric Press, 1991, pp 189–222
- Loewenstein RJ: Dissociative amnesia and dissociative fugue, in *Handbook of Dissociation*. Edited by Michaelson W, Ray HR. New York, Plenum, 1996, pp 307–336
- Loewenstein RJ: Dissociative amnesia and dissociative fugue, in *Treatment s of Psychiatric Disorders*, 3rd Edition, Vol 2. Edited by Gabbard GO. Washington, DC, American Psychiatric Press, 2001, pp 1623–1652

- Parwatikar SD, Holcomb WR, Menninger KA 2nd: The detection of malingered amnesia in accused murders. *Bull Am Acad Psychiatry Law* 13(1):97–103, 1985 3995192
- Pieper S, Out D, Bakermans-Kranenburg MJ, van Ijzendoorn MH: Behavioral and molecular genetics of dissociation: the role of the serotonin transporter gene promoter polymorphism (5-HTTLPR). *J Traumatic Stress* 24(4):373–380, 2011 21780190 10.1002/jts.20659
- Putnam FW: *Dissociation in Children and Adolescents: A Developmental Model*, New York, Guilford, 1997
- Ross CA, Miller SD, Reagor P, et al: Structured interview data on 102 cases of multiple personality disorder from four centers. *Am J Psychiatry* 147(5):596–601, 1990 2183634
- Ruedrich SL, Chu CC, Wadle CV: The amytal interview in the treatment of psychogenic amnesia. *Hosp Community Psychiatry* 36(10):1045–1046, 1985 4054860
- Sargent W, Slater E: Amnesic syndromes in war. *Proceedings of the Royal Society of Medicine* 34:757–764, 1941
- Savitz JB, van der Merwe L, Newman TK, et al: The relationship between childhood abuse and dissociation: is it influenced by catechol-O-methyltransferase (COMT) activity? *Int J Neuropsychopharmacol* 11(2):149–161, 2008 17608961
- Schacter DL: Amnesia and crime: how much do we really know? *Am Psychol* 41(3):286–295, 1986 3963616
- Spiegel D, Loewenstein RJ, Lewis-Fernández R, et al: Dissociative disorders in DSM-5. *Depress Anxiety* 28(9):824–852, 2011 21910187
- Takahashi Y: Aokigahara-jukai: suicide and amnesia in Mt. Fuji's Black Forest. *Suicide Life Threat Behav* 18(2):164–175, 1988 3420643
- Thom DA, Fenton N: Amnesias in war cases. *Am J Psychiatry* 76:437–448, 1920
- van der Hart O, Steele K, Boon S, Brown P: The treatment of traumatic memories: synthesis, realization and integration. *Dissociation* 6:162–180, 1993
- Witztum E, Margalit H, van der Hart O: Combat-induced dissociative amnesia: review and case example of generalized dissociative amnesia. *Journal of Trauma & Dissociation* 3(2):35–55, 2002

Dépersonnalisation/déréalisation

- Aderibigbe YA, Bloch RR, Walker WR: Prevalence of depersonalization and derealization experiences in a rural population. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol* 36(2):63–69, 2001 11355447
- Baker D, Hunter E, Lawrence E, et al: Depersonalisation disorder: clinical features of 204 cases. *Br J Psychiatry* 182:428–433, 2003 12724246
- Hunter EC, Sierra M, David AS: The epidemiology of depersonalisation and derealisation: a systematic review. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol* 39(1):9–18, 2004 15022041
- Lambert MV, Sierra M, Phillips ML, David AS: The spectrum of organic depersonalization: a review plus four new cases. *J Neuropsychiatry Clin Neurosci* 14(2):141–154, 2002 11983788
- Lemche E, Surguladze SA, Giampietro VP, et al: Limbic and prefrontal responses to facial emotion expressions in depersonalization. *Neuroreport* 18(5):473–477, 2007 17496806
- Medford N, Baker D, Hunter E, et al: Chronic depersonalization following illicit drug use: a controlled analysis of 40 cases. *Addiction* 98(12):1731–1736, 2003 14651505
- Phillips ML, Medford N, Senior C, et al: Depersonalization disorder: thinking without feeling. *Psychiatry Res* 108(3):145–160, 2001 11756013
- Sierra M, Senior C, Dalton J, et al: Autonomic response in depersonalization disorder. *Arch Gen Psychiatry* 59(9):833–838, 2002 12215083
- Sierra M, Baker D, Medford N, David AS: Unpacking the depersonalization syndrome: an exploratory factor analysis on the Cambridge Depersonalization Scale. *Psychol Med* 35(10):1523–1532, 2005 16164776
- Simeon D, Guralnik O, Hazlett E, et al: Feeling unreal: a PET study of depersonalization disorder. *Am J Psychiatry* 157(11):1782–1788, 2000 11058475
- Simeon D, Guralnik O, Schmeidler J, et al: The role of childhood interpersonal trauma in depersonalization disorder. *Am J Psychiatry* 158(7):1027–1033, 2001 11431223
- Simeon D, Guralnik O, Knutelska M, Schmeidler J: Personality factors associated with dissociation: temperament, defenses, and cognitive schemata. *Am J Psychiatry* 159(3):489–491, 2002 11870020
- Simeon D, Knutelska M, Nelson D, Guralnik O: Feeling unreal: a depersonalization disorder update of 117 cases. *J Clin Psychiatry* 64(9):990–997, 2003 14628973

- Simeon D, Knutelska M, Yehuda R, et al: Hypothalamic-pituitary-adrenal axis function in dissociative disorders, post-traumatic stress disorder, and healthy volunteers. *Biol Psychiatry* 61(8):966–973, 2007 17137559
- Simeon D, Kozin DS, Segal K, et al: De-constructing depersonalization: further evidence for symptom clusters. *Psychiatry Res* 157(1-3):303–306, 2008 17959254
- Simeon D, Kozin DS, Segal K, Lerch B: Is depersonalization disorder initiated by illicit drug use any different? A survey of 394 adults. *J Clin Psychiatry* 70(10):1358–1364, 2009 19538903
- Spiegel D, Loewenstein RJ, Lewis-Fernández R, et al: Dissociative disorders in DSM-5. *Depress Anxiety* 28(9):824–852, 2011 21910187 10.1002/da.20874

Troubles à symptomatologie somatique et apparentés

Le trouble à symptomatologie somatique et les autres troubles à symptomatologie somatique prévalente constituent une nouvelle catégorie du DSM-5 appelée *troubles à symptomatologie somatique et apparentés*. Ce chapitre inclut les diagnostics de trouble à symptomatologie somatique, de crainte excessive d'avoir une maladie, de trouble de conversion (trouble à symptomatologie neurologique fonctionnelle), de facteurs psychologiques influençant d'autres affections médicales, de troubles factices, d'autre trouble spécifié à symptomatologie somatique et de trouble non spécifié à symptomatologie somatique. Tous les troubles décrits dans ce chapitre ont une caractéristique commune : la prééminence de symptômes somatiques associés à une détresse et à un handicap significatifs. Les personnes présentant ces troubles à symptomatologie somatique prééminente se rencontrent principalement en soins primaires ou dans d'autres contextes médicaux mais moins fréquemment en psychiatrie ou dans d'autres structures de santé mentale. Les redéfinitions de ces diagnostics reposant sur la réorganisation de la section des troubles somatoformes du DSM-IV seront donc plus utiles aux médecins généralistes et aux autres cliniciens non psychiatres.

Le principal diagnostic de cette catégorie, le trouble à symptomatologie somatique, s'appuie sur l'existence de symptômes et de signes positifs (des symptômes somatiques pénibles associés à des pensées, des sensations et des comportements anormaux secondaires à ces symptômes) plutôt que sur l'absence d'explication médicale de cette symptomatologie somatique. La caractéristique particulière des nombreuses personnes présentant ces troubles à symptomatologie somatique ne repose pas sur les symptômes somatiques à proprement parler mais plutôt sur la manière dont ils sont présentés et interprétés. La prise en compte des composantes affectives, cognitives et comportementales dans les critères du trouble à symptomatologie somatique reflète le tableau clinique de manière plus logique et plus précise que ne pourrait le faire la seule évaluation des plaintes somatiques.

Les principes qui ont conduit aux modifications apportées au diagnostic des troubles à symptomatologie somatique et apparentés par rapport au DSM-IV sont essentiels à la compréhension des diagnostics du DSM-5. Le terme de *trouble somatoforme* du DSM-IV manquait de précision et est remplacé par *troubles à symptomatologie somatique et apparentés*. Dans le DSM-IV existait un recouvrement important entre les différents troubles somatoformes et un manque de précision sur les frontières de ces diagnostics. Bien que les personnes présentant ces troubles soient vues principalement dans des environnements médicaux plutôt qu'en santé mentale, les médecins non psychiatres trouvaient les diagnostics DSM-IV de troubles somatoformes difficiles à comprendre et à utiliser. La présente classification du DSM-5 reconnaît ces recouvrements en diminuant le nombre total des troubles ainsi que celui de leurs sous-catégories.

Les critères antérieurs étaient excessivement centrés sur les symptômes médicalement inexpliqués. De tels symptômes sont présents à des degrés divers, en particulier dans le trouble de conversion, mais les troubles à symptomatologie somatique sont également susceptibles d'être associés à des affections médicales. La détermination du caractère médicalement inexpliqué d'un symptôme reste d'une fiabilité limitée et faire reposer un diagnostic sur l'absence d'une telle explication reste problématique et renforce le dualisme corps-esprit. Il est inapproprié de donner un diagnostic de

trouble mental à une personne simplement du fait de l'absence de démonstration d'une étiologie médicale. En outre, la présence d'un diagnostic médical n'exclut pas la possibilité d'un trouble mental comorbide incluant notamment les troubles à symptomatologie somatique et apparentés. Il est possible que du fait de cette focalisation excessive sur l'absence d'explication médicale, ces diagnostics puissent être considérés par les patients comme péjoratifs et avilissants car impliquant que leurs symptômes physiques ne sont pas « réels ». La nouvelle classification définit le principal diagnostic, le trouble à symptomatologie somatique, sur la base de symptômes positifs (symptômes somatiques pénibles associés à des pensées, des sentiments et des comportements anormaux secondaires à ces symptômes). Cependant, les symptômes médicalement inexplicables restent une caractéristique essentielle du trouble de conversion, et de la grosseur nerveuse (autre trouble spécifié à symptomatologie somatique) car il est possible de démontrer définitivement dans ces troubles que les symptômes ne sont pas consistants avec une explication médicale.

Il est important de noter que d'autres troubles mentaux peuvent se manifester initialement par des symptômes somatiques prédominants (p. ex. le trouble dépressif caractérisé, le trouble panique). De tels diagnostics peuvent rendre compte de la symptomatologie somatique ou être présents parallèlement à l'un des troubles à symptomatologie somatique ou apparenté de ce chapitre. Il existe également une comorbidité médicale considérable parmi les personnes présentant des somatisations. Bien que les symptômes somatiques soient fréquemment associés avec la détresse psychologique et les troubles psychopathologiques, certains des troubles à symptomatologie somatique et apparentés peuvent survenir de façon spontanée et leur étiologie demeurer obscure. Les troubles anxieux et le trouble dépressif peuvent accompagner les troubles à symptomatologie somatique et apparentés. La composante somatique ajoute un élément de sévérité et de complexité aux troubles dépressifs et anxieux dans lesquels elle entraîne une sévérité et une altération fonctionnelle plus importantes voire une résistance aux traitements traditionnels. Dans de rares cas, le degré de préoccupation peut être si sévère qu'il peut faire évoquer un diagnostic de trouble délirant.

Un certain nombre de facteurs sont associés aux troubles à symptomatologie somatique et apparentés. Ces facteurs incluent une vulnérabilité génétique et biologique (p. ex. augmentation de la sensibilité à la douleur), des expériences traumatiques précoces (p. ex. violence, abus, privation), des facteurs d'apprentissage (p. ex. attention d'autrui induite par la maladie, absence de renforcement des expressions non somatiques de la détresse) ainsi que des normes culturelles et sociales qui visent à dévaluer et à stigmatiser la souffrance psychologique comparativement à la souffrance physique. Des différences culturelles dans les soins médicaux peuvent influencer la présentation, la reconnaissance et la prise en charge de ces tableaux somatiques. La variabilité de ces présentations symptomatiques est probablement la résultante de l'interaction de facteurs multiples dans des contextes culturels qui influencent la manière dont les personnes identifient et classifient les sensations corporelles, perçoivent la maladie et recherchent une aide médicale à leur sujet. De ce fait, les présentations somatiques peuvent être vues comme l'expression d'une souffrance personnelle dépendante du contexte culturel et social.

Tous ces troubles sont caractérisés par une focalisation prédominante sur des problèmes somatiques et par leur présentation initiale dans des environnements médicaux plutôt qu'en santé mentale. Le trouble à symptomatologie somatique permet de caractériser plus utilement d'un point de vue clinique les personnes qui auraient reçu un diagnostic de trouble de somatisation. En outre, environ 75 % des personnes diagnostiquées antérieurement comme hypocondriaques le seront sous le diagnostic de trouble à symptomatologie somatique. Cependant, environ 25 % des personnes hypocondriaques ont un niveau élevé d'anxiété concernant la santé en l'absence de symptômes

somatiques et les symptômes de la plupart d'entre elles ne rempliraient pas les critères d'un trouble anxieux. Le diagnostic DSM-5 de crainte excessive d'avoir une maladie concerne ces personnes. La crainte excessive d'avoir une maladie pourrait être considérée soit dans cette catégorie diagnostique soit dans celle des troubles anxieux. Du fait de la focalisation importante sur les préoccupations somatiques et du fait que la crainte excessive de la maladie est le plus souvent reconnue dans un environnement médical, ce trouble est pour des raisons pratiques inclus dans la catégorie des troubles à symptomatologie somatique et apparentés. Dans le trouble de conversion, la caractéristique essentielle repose sur l'existence de symptômes neurologiques qui, après une évaluation neurologique appropriée, s'avèrent incompatibles avec une physiopathologie neurologique. Les facteurs psychologiques influençant d'autres affections médicales sont aussi inclus dans ce chapitre. La caractéristique essentielle de cette catégorie repose sur la présence d'un ou de plusieurs facteurs psychologiques ou comportementaux qui vont influencer négativement un trouble médical en augmentant le risque associé de souffrance, de mortalité ou d'invalidité. De même que les autres troubles à symptomatologie somatique et apparentés, le trouble factice rassemble des problèmes persistants relatifs à la perception et à l'identification de la maladie. Dans la grande majorité des cas rapportés de troubles factices, à la fois auto-induits ou imposés à autrui, les patients sont convaincus d'avoir des symptômes somatiques et une affection médicale. Les catégories « autre trouble spécifié à symptomatologie somatique » et « trouble non spécifié à symptomatologie somatique » incluent les cas dans lesquels certains critères du trouble à symptomatologie somatique ou de la crainte excessive de la maladie sont présents mais pas dans leur intégralité, de même que la grossesse nerveuse.

Trouble à symptomatologie somatique

Critères diagnostiques

300.82 (F45.1)

- A. Un ou plusieurs symptômes somatiques causes de détresse ou entraînant une altération significative de la vie quotidienne.
- B. Pensées, sentiments ou comportements excessifs liés aux symptômes somatiques ou à des préoccupations sur la santé suscitées par ces symptômes, se manifestant par au moins un des éléments suivants :
 - 1. Pensées persistantes et excessives concernant la gravité de ses symptômes.
 - 2. Persistance d'un niveau élevé d'anxiété concernant la santé ou les symptômes.
 - 3. Temps et énergie excessifs dévolus à ces symptômes ou aux préoccupations concernant la santé.
- C. Bien qu'un symptôme somatique donné puisse ne pas être continuellement présent, l'état symptomatique est durable (typiquement plus de 6 mois).

Spécifier si :

Avec douleur prédominante (antérieurement trouble douloureux) : Cette spécification concerne les individus dont les symptômes somatiques consistent principalement en une douleur.

Spécifier si :

Chronique : Une évolution chronique est caractérisée par des symptômes sévères, un handicap marqué et une durée prolongée (plus de 6 mois).

Spécifier la sévérité actuelle :

Léger : Seulement l'un des symptômes spécifiés au critère B est présent.

Moyen : Deux symptômes ou plus spécifiés au critère B sont présents.

Grave : Deux ou plus des symptômes spécifiés au critère B sont présents et sont associés à des plaintes somatiques multiples (ou à un symptôme somatique très sévère).

Caractéristiques diagnostiques

Les personnes ayant un trouble à symptomatologie somatique présentent de façon caractéristique des symptômes somatiques banals et multiples entraînant une détresse ou une altération significative de la vie quotidienne (critère A) bien que dans certains cas un seul symptôme sévère, le plus souvent douloureux, soit présent. Ces symptômes peuvent être spécifiques (p. ex. une douleur localisée) ou relativement non spécifiques (p. ex. fatigue). Ces symptômes représentent parfois des sensations ou des inconforts corporels normaux qui n'ont habituellement pas de signification pathologique sérieuse. Des symptômes somatiques sans explication médicale évidente ne sont pas suffisants pour faire ce diagnostic. La souffrance de la personne est authentique, qu'elle soit ou non explicable médicalement.

Les symptômes peuvent ou non être associés avec une autre affection médicale. Le diagnostic de trouble à symptomatologie somatique et celui d'un trouble médical comorbide ne sont pas mutuellement exclusifs et sont même fréquemment associés. Par exemple, une personne peut devenir sérieusement handicapée par les symptômes d'un trouble à symptomatologie somatique après un infarctus du myocarde non compliqué même si l'infarctus du myocarde lui-même n'a pas entraîné d'incapacité. S'il existe un autre trouble médical ou un risque élevé de le développer (p. ex. antécédents familiaux importants), les pensées, les sentiments et les comportements associés avec cette maladie sont excessifs (critère B).

Les personnes ayant un trouble à symptomatologie somatique ont tendance à présenter des niveaux très élevés de soucis concernant la maladie (critère B). Elles interprètent leurs symptômes somatiques comme excessivement menaçants, dangereux ou perturbateurs et anticipent le pire à propos de leur santé. Même en cas de preuve du contraire, certains patients continuent à croire en la sévérité de leurs symptômes. Dans les troubles à symptomatologie somatique grave, les préoccupations concernant la santé peuvent occuper un rôle central dans la vie de la personne et devenir une caractéristique de son identité envahissant ses relations interpersonnelles.

Typiquement, ces personnes présentent une détresse focalisée principalement sur les symptômes somatiques et leur signification. Lorsqu'elles sont interrogées sur cette détresse, certaines personnes la décrivent en relation avec d'autres aspects de leur vie tandis que d'autres dénie toute sorte de détresse autre que leurs symptômes somatiques. La qualité de vie relative à la santé est souvent altérée à la fois du point de vue physique et mental. Dans les troubles à symptomatologie somatique grave, l'incapacité est marquée et lorsqu'elle persiste, le trouble peut mener à l'invalidité.

Il existe souvent un degré élevé d'utilisation des services médicaux qui atténue rarement les préoccupations de la personne. En conséquence, le patient peut rechercher de l'aide auprès de médecins multiples pour les mêmes symptômes. Ces individus semblent souvent peu sensibles aux interventions médicales et les nouvelles interventions ne font qu'exacerber les symptômes présents. Quelques personnes présentant ce trouble sont particulièrement sensibles aux effets secondaires des médicaments. Certaines pensent que les évaluations et les traitements médicaux ont été inadéquats.

Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

Les caractéristiques cognitives incluent une attention focalisée sur les symptômes somatiques, l'attribution de sensations corporelles normales à une maladie physique (éventuellement associées à des interprétations catastrophiques), des soucis concernant la maladie, et la peur que toute activité physique puisse nuire à la santé. Les caractéristiques comportementales associées pertinentes pour le diagnostic peuvent inclure une recherche répétée d'anomalies corporelles, la recherche répétée d'aide et de rassurement médical et l'évitement de l'activité physique (Voigt et al. 2010). Ces caractéristiques comportementales sont plus prononcées dans les troubles à symptomatologie somatique sévères et persistants.

Elles sont habituellement associées à des demandes fréquentes d'aide médicale pour différents symptômes somatiques. Cela peut conduire à des consultations médicales dans lesquelles les personnes sont tellement focalisées sur leurs préoccupations concernant les symptômes somatiques qu'elles s'avèrent incapables d'aborder d'autres sujets. Tout rassurement par les médecins suggérant que les symptômes ne sont pas liés à une maladie physique sérieuse tend à être transitoire et/ou interprété par le patient comme le fait que les symptômes ne sont pas considérés comme sérieux par le médecin. La focalisation sur les symptômes somatiques étant la caractéristique principale du trouble, les personnes ayant un trouble à symptomatologie somatique se présentent généralement dans des services de santé médicaux plutôt que dans ceux de santé mentale. La suggestion d'une consultation d'un spécialiste de santé mentale peut être reçue avec surprise voire clairement refusée par les individus présentant un trouble à symptomatologie somatique.

Quand le trouble à symptomatologie somatique est associé à des troubles dépressifs, il existe une augmentation du risque suicidaire. En revanche, on ne sait pas si le trouble à symptomatologie somatique est associé à un risque suicidaire indépendant de son lien avec le trouble dépressif.

Prévalence

La prévalence du trouble à symptomatologie somatique est inconnue. Cependant, elle est probablement supérieure à celle du diagnostic DSM-IV de trouble de somatisation (< 1 %) mais inférieure à celle du trouble somatoforme indifférencié (approximativement de 19 %) (Creed et Barsky 2004 ; Hiller et al. 2006). La prévalence du trouble à symptomatologie somatique dans la population générale adulte est probablement de 5-7 % (Rief et al. 2011). Les femmes tendent à rapporter plus de symptômes somatiques que les hommes et la prévalence du trouble à symptomatologie somatique est de ce fait probablement plus élevée chez les femmes (Creed et Barsky 2004 ; Hausteiner-Wiehle et al. 2011).

Développement et évolution

Chez les sujets âgés, les troubles à symptomatologie somatique et les affections médicales comorbides sont fréquents et une attention particulière pour le critère B est nécessaire pour établir le diagnostic. Le trouble à symptomatologie somatique est probablement sous-diagnostiqué chez les sujets âgés soit parce que certains symptômes somatiques (p. ex. douleurs, fatigue) sont considérés comme faisant partie du vieillissement normal, soit parce que les soucis concernant la santé sont considérés comme « compréhensibles » chez le sujet âgé du fait de la fréquence plus élevée d'affections médicales générales et de traitements que chez les sujets jeunes. Le trouble dépressif comorbide est fréquent chez le sujet âgé qui présente de nombreux symptômes somatiques (Wijeratne et al. 2007).

Chez l'enfant, les symptômes les plus fréquents sont des douleurs abdominales, de la fatigue, des nausées et des céphalées récurrentes (Dell et Campo 2011 ; Weisblatt et al. 2011). Un symptôme unique prééminent est plus fréquent chez l'enfant que chez l'adulte. Alors que les jeunes enfants peuvent présenter des plaintes somatiques, ils s'inquiètent rarement sur la « maladie » en soi avant l'adolescence. La réponse des parents aux symptômes est importante car elle peut déterminer le niveau de détresse et l'évolution. Ce sont les parents qui peuvent également influencer l'interprétation des symptômes, l'absentéisme scolaire et la recherche d'une aide médicale.

Facteurs de risque et pronostiques

Tempéramentaux. Le trait de personnalité d'affectivité négative (névrosisme) a été identifié comme un corollaire indépendant/facteur de risque d'un nombre important de symptômes somatiques (Creed et al. 2012). L'anxiété ou la dépression comorbides sont fréquentes et peuvent exacerber les symptômes et l'invalidité.

Environnementaux. Le trouble à symptomatologie somatique est plus fréquent chez les personnes ayant un niveau d'éducation et un statut socio-économique faibles ainsi que chez celles qui ont fait récemment l'expérience d'événements de vie stressants (Creed et Barsky 2004 ; Creed et al. 2012 ; Deary et al. 2007).

Facteurs influençant l'évolution. Les symptômes somatiques persistants sont associés à certaines caractéristiques démographiques (sexe féminin, âge avancé, moindre niveau d'éducation, moindre statut socio-économique, chômage), des antécédents d'abus sexuels ou d'autres activités durant l'enfance, l'existence d'une pathologie physique ou psychiatrique chronique (dépression, anxiété, trouble dépressif persistant [dysthymie], panique), le stress social, des facteurs sociaux de renforcement tels que des bénéfices liés à la maladie (Deary et al. 2007). Les facteurs cognitifs susceptibles de modifier l'évolution clinique incluent la sensibilisation à la douleur, l'attention accrue aux sensations corporelles et l'attribution des symptômes corporels à une possible maladie médicale plutôt que leur reconnaissance comme liés à un phénomène normal ou à un stress psychologique (Deary et al. 2007 ; Rief et Broadbent 2007 ; Rief et al. 2004).

Questions diagnostiques liées à la culture

Les symptômes somatiques sont prédominants dans le cadre des « syndromes liés à la culture » de nature variée. Un nombre élevé de symptômes somatiques est retrouvé dans les études effectuées en population générale ou en soins primaires dans le monde avec une présentation similaire concernant les symptômes somatiques les plus fréquents, le handicap et la recherche de traitement qui y sont associés (Hausteiner-Wiehle et al. 2011 ; Hiller et al. 2006 ; Sumathipala et al. 2008). La relation existant entre le nombre de symptômes somatiques et l'inquiétude concernant la santé est similaire dans différentes cultures et des soucis importants concernant la santé sont associés avec le handicap et une augmentation de la recherche de traitements au travers de différentes cultures (Lee et al. 2011 ; Rief et al. 2001). La relation entre un nombre élevé de symptômes somatiques et la dépression est également très similaire dans le monde et entre différentes cultures au sein d'un même pays.

En dépit de ces similarités, des différences entre les symptômes somatiques existent entre les cultures et les groupes ethniques. La description des symptômes somatiques varie en fonction de facteurs linguistiques ou d'autres facteurs culturels locaux. Ces présentations somatiques ont été décrites comme des « idiomes de détresse » car les symptômes somatiques peuvent avoir une signification particulière et modifier les relations patient-médecin en fonction de contextes culturels spécifiques. Le « burnout », les sensations de lourdeur ou les plaintes concernant les « gaz », trop de chaleur au niveau du corps, ou des brûlures dans la tête sont des exemples de symptômes qui sont fréquents dans certains groupes culturels ou ethniques mais rares dans d'autres (Kirmayer et Sartorius 2007). Les modèles explicatifs varient également et les symptômes somatiques peuvent être attribués de façon variable : à des stress familiaux, professionnels ou environnementaux, à des affections médicales générales, à la suppression de sentiments d'agressivité ou de ressentiment, ou à certains phénomènes culturels spécifiques tels que la perte de sperme (Hausteiner-Wiehle et al. 2011 ; Sumathipala et al. 2004 ; Sumathipala et al. 2008). Il peut également exister des différences dans la recherche de traitements médicaux au sein de différents groupes culturels s'ajoutant aux différences dues à la variabilité d'accès aux services de soins médicaux. La recherche de traitement pour des symptômes somatiques multiples dans des cliniques de médecine générale est un phénomène mondial survenant avec une fréquence similaire parmi les groupes ethniques d'un même pays (Creed 2011).

Retentissement fonctionnel du trouble à symptomatologie somatique

Le trouble est associé avec une altération marquée de l'état de santé. De nombreuses personnes présentant des troubles à symptomatologie somatique sont à risque de présenter une diminution de leur note globale d'état de santé de plus de deux écarts types par rapport aux normes de la population (Creed 2011 ; Creed et Barsky 2004).

Diagnostic différentiel

Si les symptômes somatiques sont compatibles avec l'existence d'un trouble mental (p. ex. trouble panique) et si les critères diagnostiques pour ce trouble sont remplis, ce trouble psychiatrique doit alors être considéré comme un diagnostic alternatif ou additionnel. Un diagnostic séparé de trouble à symptomatologie somatique ne peut être fait si les symptômes somatiques et les pensées, les émotions ou les comportements associés surviennent uniquement au cours d'un épisode dépressif caractérisé. Si, comme cela est fréquent, les critères sont à la fois remplis pour le trouble à symptomatologie somatique et un autre trouble mental, les deux troubles doivent être retenus car les deux peuvent requérir un traitement.

Autres affections médicales. La présence de symptômes somatiques d'étiologie incertaine n'est pas en elle-même suffisante pour faire le diagnostic de trouble à symptomatologie somatique. Les symptômes de nombreuses personnes présentant des troubles comme le syndrome du côlon irritable ou la fibromyalgie ne remplissent pas nécessairement les critères nécessaires au diagnostic de trouble à symptomatologie somatique (critère B). À l'inverse, la présence de symptômes somatiques d'un trouble médical spécifique (p. ex. diabète ou troubles cardiaques) n'exclut pas le diagnostic de trouble à symptomatologie somatique si les critères de ce dernier sont remplis.

Trouble panique. Dans le trouble panique, les symptômes somatiques et l'anxiété concernant la santé surviennent dans le cadre d'épisodes aigus tandis que dans le trouble à symptomatologie somatique, l'anxiété et les symptômes somatiques sont plus persistants.

Anxiété généralisée. Les personnes présentant une anxiété généralisée s'inquiètent à propos d'événements, de situations et d'activités multiples parmi lesquels va figurer leur santé. La préoccupation principale ne porte pas habituellement sur les symptômes somatiques ou la peur de la maladie comme c'est le cas dans le trouble à symptomatologie somatique.

Troubles dépressifs. Les troubles dépressifs s'accompagnent fréquemment de symptômes somatiques. Cependant, ils s'en différencient du fait de la présence des symptômes dépressifs fondamentaux, baisse de l'humeur (dysphorie) et anhédonie.

Crainte excessive d'avoir une maladie. Si la personne présente des inquiétudes envahissantes concernant la santé mais peu ou pas de symptômes somatiques, il peut être plus approprié de prendre en considération le diagnostic de crainte excessive d'avoir une maladie.

Trouble de conversion (trouble à symptomatologie neurologique fonctionnelle). Dans le trouble de conversion, le symptôme d'appel est la perte de fonction (p. ex. d'un membre) tandis que dans le trouble à symptomatologie somatique, l'importance est mise sur la détresse entraînée par des symptômes particuliers. Les caractéristiques attendues au critère B du trouble à symptomatologie somatique peuvent être utiles pour différencier les deux types de troubles.

Trouble délirant. Dans le trouble à symptomatologie somatique, le fait que la personne croit que ses symptômes somatiques sont le reflet d'une maladie physique sérieuse

sous-jacente ne fait pas l'objet d'une intensité délirante. Néanmoins, les convictions de la personne concernant les symptômes somatiques peuvent être fermement soutenues. À l'inverse, dans le trouble délirant, sous-type somatique, les convictions et les comportements concernant le symptôme somatique sont plus forts que ceux existant dans le trouble à symptomatologie somatique.

Obsession d'une dysmorphie corporelle. Dans l'obsession d'une dysmorphie corporelle, la personne est préoccupée de façon excessive par un défaut perçu au niveau de ses caractéristiques physiques. À l'inverse, dans le trouble à symptomatologie somatique, la préoccupation concernant les symptômes somatiques reflète la peur d'une maladie sous-jacente et non un défaut d'apparence.

Trouble obsessionnel-compulsif. Dans le trouble à symptomatologie somatique, les idées récurrentes concernant les symptômes somatiques ou la maladie sont moins intrusives et la personne ayant ce trouble ne présente pas les comportements répétitifs associés visant à réduire l'anxiété qui surviennent dans le trouble obsessionnel-compulsif.

Comorbidité

Le trouble à symptomatologie somatique est associé à un taux élevé de comorbidité avec les troubles médicaux ainsi qu'avec les troubles dépressifs et anxieux. Quand un trouble médical comorbide est présent, le degré d'invalidité est plus marqué que ce qui serait attendu du fait de la maladie physique seule. Quand un symptôme individuel remplit les critères diagnostiques pour le trouble à symptomatologie somatique, ce trouble doit être diagnostiqué ; cependant, du fait de la fréquente comorbidité, notamment avec les troubles dépressifs et anxieux, la preuve de l'existence de ces diagnostics comorbides doit être recherchée.

Crainte excessive d'avoir une maladie

Critères diagnostiques

300.7 (F45.21)

- A. Préoccupation concernant le fait d'avoir ou de développer une maladie grave.
- B. Les symptômes somatiques sont absents ou s'ils sont présents, ils sont d'intensité mineure. Si un autre problème médical est présent ou en cas de risque notable de développement d'une affection médicale (p. ex. du fait de la présence d'antécédents familiaux importants), la préoccupation est clairement excessive ou disproportionnée.
- C. Il existe un degré important d'anxiété concernant la santé et la personne s'inquiète facilement de son état de santé personnel.
- D. La personne présente des comportements excessifs par rapport à sa santé (p. ex. effectue des vérifications répétées de son corps à la recherche des signes d'une maladie) ou présente un évitement inadapté (p. ex. évite les rendez-vous médicaux et les hôpitaux).
- E. Les préoccupations concernant la maladie sont présentes depuis au moins 6 mois mais la nature de la maladie qui est spécifiquement anticipée peut avoir changé durant cette période de temps.
- F. La préoccupation relative aux maladies n'est pas mieux expliquée par un autre trouble mental tel qu'un trouble à symptomatologie somatique, un trouble panique, une anxiété généralisée, une obsession d'une dysmorphie corporelle, un trouble obsessionnel-compulsif ou un trouble délirant à type somatique.

Spécifier le type :

À type de demande de soins : Les soins médicaux incluant les visites chez des médecins ou les examens complémentaires sont utilisés de façon fréquente.

À type évitant les soins : Les soins médicaux sont rarement utilisés.

Caractéristiques diagnostiques

La plupart des cas d'hypocondrie sont maintenant classifiés sous le diagnostic de trouble à symptomatologie somatique ; cependant, dans une minorité de cas, le diagnostic de crainte excessive d'avoir une maladie peut s'appliquer. La crainte excessive d'avoir une maladie concerne une préoccupation liée au fait d'avoir ou de pouvoir développer une affection médicale sérieuse et non diagnostiquée (critère A). Les symptômes somatiques sont absents ou, s'ils sont présents, ils sont seulement de faible intensité (critère B). Une évaluation somatique approfondie ne permet pas d'identifier une affection médicale sérieuse qui pourrait rendre compte des inquiétudes de la personne. Bien que cette inquiétude puisse être liée à des signes ou des sensations physiques non pathologiques, la détresse du sujet n'est pas liée principalement à la plainte physique en elle-même mais plutôt à l'anxiété concernant la signification ou la cause de cette plainte (c.-à-d. le diagnostic médical suspecté). Si un signe ou un symptôme physique sont présents, il s'agit souvent d'une sensation physiologique normale (p. ex. une sensation vertigineuse orthostatique), d'un dysfonctionnement bénin et limité (p. ex. des acouphènes transitoires) ou d'un inconfort somatique qui n'est pas généralement considéré comme indicateur d'une maladie (p. ex. des éructations). Si une pathologie médicale diagnosticable est présente, l'anxiété et les préoccupations de la personne sont clairement excessives et disproportionnées par rapport à la sévérité du trouble (critère B). Comme les preuves empiriques et la littérature existantes portent sur la définition de l'hypocondrie dans les éditions précédentes du DSM, il n'est pas sûr qu'elles puissent s'appliquer précisément à la description de ce nouveau diagnostic.

Les inquiétudes et les préoccupations liées à l'idée qu'une personne puisse être malade sont accompagnées d'une anxiété notable concernant la santé et la maladie (critère C). Les individus présentant une crainte excessive d'avoir une maladie s'inquiètent facilement à propos d'affections médicales, notamment quand ils entendent parler de quelqu'un tombé malade ou lorsqu'ils lisent des nouvelles portant sur la santé. Leurs inquiétudes concernant une maladie non diagnostiquée ne sont pas calmées par les rassurements médicaux habituels, la négativité des tests diagnostiques ou une évolution bénigne. Les tentatives de rassurement du médecin et le traitement symptomatique ne sont généralement pas suffisants pour diminuer l'inquiétude de la personne et peuvent éventuellement l'augmenter. Les préoccupations concernant les maladies tiennent une place importante dans la vie de l'individu, affectent ses activités et peuvent même entraîner une invalidité. La maladie devient une caractéristique centrale de l'identité et de l'auto-perception de la personne, un sujet fréquent de son discours social et une réponse caractéristique aux événements stressants de la vie. Les individus présentant ce trouble s'auto-examinent de façon répétée (p. ex. en examinant leur gorge dans un miroir) (critère D). Elles s'informent de manière excessive sur la maladie suspectée (p. ex. sur Internet) et recherchent de façon répétée un rassurement auprès de leur famille, de leurs amis ou des médecins. Ces ruminations incessantes deviennent souvent frustrantes pour l'entourage et peuvent entraîner une tension considérable au sein de la famille. Dans certains cas, l'anxiété mène à un évitement exagéré de situations (p. ex. rendre visite à des parents malades) ou d'activités (p. ex. l'exercice) dont ces personnes craignent qu'elles puissent mettre leur santé en danger.

Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

Du fait qu'elles se croient malades, les personnes présentant une crainte excessive d'avoir une maladie se rencontrent beaucoup plus fréquemment dans les structures médicales que dans celles de santé mentale. La majorité des individus présentant une crainte excessive d'avoir une maladie bénéficient de soins médicaux extensifs mais insatisfaisants bien que certains puissent être trop anxieux pour rechercher un avis

médical. Ils ont en général un taux élevé d'utilisation des services médicaux mais ne fréquentent pas plus les services de santé mentale que la population générale (Barsky et al. 2001 ; Creed 2011). Ils consultent souvent de multiples médecins pour le même problème et obtiennent de façon répétitive des résultats négatifs aux tests diagnostiques. Chez certains, la prise en charge médicale peut mener à une exacerbation paradoxale de leur anxiété ou à des complications iatrogènes liées aux tests et aux procédures diagnostiques. Les personnes présentant ce trouble sont en général insatisfaites des soins médicaux, les trouvent inutiles et pensent souvent qu'elles ne sont pas prises au sérieux par les médecins (Barsky et al. 1991a). Chez certaines, cette crainte peut être justifiée car les médecins peuvent parfois être rejetants ou répondre à leur demande avec frustration ou hostilité. Ce type de réponse peut occasionnellement entraîner le défaut de diagnostic d'une affection médicale existant.

Prévalence

Les estimations de prévalence de la crainte excessive d'avoir une maladie reposent sur les estimations des diagnostics DSM-III et DSM-IV d'hypocondrie. La prévalence à 1 ou 2 ans de la crainte excessive d'avoir une maladie et/ou de la conviction d'être atteint d'une maladie dans les sondages en population générale varie de 1,3 à 10 % (Noyes et al. 2005 ; Rief et al. 2001). Dans les populations médicales ambulatoires, les taux de prévalence à 6 mois ou 1 an varient entre 3 et 8 % (Barsky et al. 1990 ; Gureje et al. 1997). La prévalence du trouble est la même chez les hommes et les femmes (Escobar et al. 1998 ; Rief et al. 2001).

Développement et évolution

Le développement et l'évolution de la crainte excessive d'avoir une maladie sont mal connus. La crainte excessive d'avoir une maladie est vue en général comme une condition chronique sujette à rechutes avec un âge de début chez l'adulte jeune ou d'âge moyen. Dans les études faites en population générale, la crainte excessive d'avoir une maladie augmente avec l'âge (Rief et al. 2001) mais l'âge des individus présentant en milieu médical une crainte importante d'avoir une maladie ne diffère pas de celui des patients vus dans d'autres environnements (Barsky et al. 1990 ; Gureje et al. 1997). Chez les sujets âgés, la crainte excessive d'avoir une maladie se focalise fréquemment sur les pertes de mémoire ; le trouble est probablement rare chez l'enfant.

Facteurs de risque et pronostiques

Environnementaux. La crainte excessive d'avoir une maladie peut parfois être provoquée par un événement de vie majeur ou par une menace sérieuse mais ultimement bénigne concernant la santé de la personne. Des antécédents d'abus ou de maladie grave dans l'enfance peuvent prédisposer au développement du trouble chez l'adulte (Noyes et al. 2002).

Facteur influençant l'évolution. Approximativement un tiers à la moitié des personnes ayant une crainte excessive d'avoir une maladie présente une évolution transitoire (Noyes et al. 1994a) qui est associée avec une moindre comorbidité psychiatrique, une comorbidité médicale accrue et une moindre sévérité de la crainte excessive d'avoir une maladie (Barsky et al. 1993 ; Noyes et al. 1994b).

Questions diagnostiques liées à la culture

Le diagnostic doit être posé avec prudence chez les personnes dont les idées à propos de la maladie sont congruentes avec des convictions largement partagées liées à la culture. Il existe peu de données sur la phénoménologie du trouble dans différentes cultures

bien que sa prévalence semble similaire dans des pays variés aux cultures diverses (Gureje et al. 1997).

Retentissement fonctionnel de la crainte excessive d'avoir une maladie

La crainte excessive de la maladie entraîne un handicap social substantiel et une altération des conditions physiques et de la qualité de vie relative à la santé (Escobar et al. 1998 ; Gureje et al. 1997 ; Noyes et al. 1994a). Les préoccupations concernant la santé interfèrent souvent avec les relations interpersonnelles, détériorent la vie familiale et impactent les performances occupationnelles.

Diagnostic différentiel

Autres affections médicales. Le premier diagnostic différentiel à prendre en considération est l'existence d'un trouble médical sous-jacent, notamment de problèmes neurologiques ou endocriniens, d'un cancer occulte ou d'autres maladies affectant des systèmes multiples. La présence d'une pathologie médicale n'exclut pas la possibilité de coexistence de la crainte excessive d'avoir une maladie. Si une affection médicale est présente, l'anxiété relative à la santé et à la maladie est clairement disproportionnée par rapport à la sévérité de cette dernière. Des préoccupations transitoires liées à une affection médicale ne constituent pas une crainte excessive d'avoir une maladie.

Troubles de l'adaptation. L'anxiété relative à la santé est une réponse normale à un problème sérieux et n'est pas un trouble mental. C'est une anxiété non pathologique relative à la santé qui peut être liée à une affection médicale et est alors typiquement limitée dans le temps. Si l'anxiété concernant la santé est suffisamment sévère, un trouble de l'adaptation peut être diagnostiqué. Cependant, c'est seulement quand l'anxiété concernant la santé est suffisamment durable, sévère et préoccupante qu'une crainte excessive d'avoir une maladie pourra être diagnostiquée. De ce fait, le diagnostic requiert la présence continue et disproportionnée de cette anxiété relative à la santé depuis au moins 6 mois.

Troubles à symptomatologie somatique. Le trouble à symptomatologie somatique est diagnostiqué quand des symptômes somatiques significatifs sont présents. À l'inverse, les personnes présentant une crainte excessive d'avoir une maladie ont des symptômes somatiques minimes et sont principalement préoccupées par l'idée qu'elles puissent être malades.

Troubles anxieux. Dans l'anxiété généralisée, les personnes s'inquiètent de situations, d'événements ou d'activités multiples, l'un d'entre eux pouvant concerner la santé. Dans le trouble panique, la personne peut s'inquiéter du fait que l'attaque de panique soit symptomatique d'une affection médicale, cependant bien que ces individus puissent être anxieux à propos de leur santé, leur anxiété est typiquement très aiguë et épisodique. Dans la crainte excessive d'avoir une maladie, l'anxiété et les peurs concernant la santé sont plus persistantes et durables. Les personnes présentant une crainte excessive d'avoir une maladie peuvent présenter des attaques de panique qui sont provoquées par leurs inquiétudes concernant la maladie.

Troubles obsessionnels-compulsifs et apparentés. Les personnes présentant une crainte excessive d'avoir une maladie peuvent avoir des pensées intrusives concernant l'existence d'une maladie et également des comportements compulsifs associés (p. ex. la recherche de rassurement). Cependant, dans la crainte excessive d'avoir une maladie, les préoccupations sont habituellement focalisées sur le fait d'être malade, alors que dans le trouble obsessionnel-compulsif (TOC), les pensées sont intrusives et le plus souvent focalisées sur la peur de pouvoir développer une maladie dans l'avenir. La plupart des personnes présentant un TOC ont des obsessions ou des compulsions impliquant

d'autres préoccupations qui s'ajoutent aux peurs concernant le fait de contracter une maladie. Dans l'obsession d'une dysmorphie corporelle, les préoccupations se limitent à l'apparence physique de la personne, considérée comme disgracieuse ou anormale.

Trouble dépressif caractérisé. Certaines personnes présentant un épisode dépressif caractérisé ont des ruminations concernant leur santé et s'inquiètent excessivement de pouvoir être malades. Un diagnostic séparé de crainte excessive d'avoir une maladie ne peut être établi si ces préoccupations surviennent seulement durant l'épisode dépressif caractérisé. Cependant, si les inquiétudes excessives concernant la maladie persistent après la rémission de l'épisode dépressif caractérisé, le diagnostic de crainte excessive d'avoir une maladie peut être pris en considération.

Troubles psychotiques. Les personnes présentant une crainte excessive d'avoir une maladie ne sont pas délirantes et peuvent reconnaître la possibilité que la maladie qu'elles craignent n'existe pas. Leurs idées n'atteignent pas la rigidité et l'intensité de celles rencontrées dans les délires somatiques existant au cours des troubles psychotiques (p. ex. schizophrénie, trouble délirant de type somatique, trouble dépressif caractérisé avec caractéristiques psychotiques). Les véritables idées délirantes somatiques sont généralement plus bizarres (p. ex. qu'un organe est mort ou en train de pourrir) que les préoccupations observées dans la crainte excessive d'avoir une maladie. Ces préoccupations, bien que non fondées en réalité, demeurent plausibles.

Comorbidité

La crainte excessive d'avoir une maladie étant un nouveau diagnostic, ses comorbidités exactes demeurent inconnues. L'hypocondrie peut coexister avec les troubles anxieux (en particulier l'anxiété généralisée, le trouble panique et le TOC) et dans les troubles dépressifs (Barsky et al. 1992 ; Simon et al. 2001). Approximativement, deux tiers des personnes présentant une crainte excessive d'avoir une maladie pourraient avoir au moins un autre trouble mental comorbide (Barsky et al. 1992 ; Noyes et al. 1994b). Les personnes présentant une crainte excessive d'avoir une maladie peuvent avoir un risque plus élevé de trouble à symptomatologie somatique et de troubles de la personnalité (Barsky et al. 1992 ; Bass et Murphy 1995 ; Kirmayer et al. 1994).

Trouble de conversion (trouble à symptomatologie neurologique fonctionnelle)

Critères diagnostiques

- A. Un ou plusieurs symptômes d'altération de la motricité volontaire ou des fonctions sensorielles.
- B. Les données cliniques démontrent l'incompatibilité entre les symptômes et une affection neurologique ou médicale reconnue.
- C. Les symptômes ou les handicaps ne sont pas mieux expliqués par un autre trouble médical ou mental.
- D. Le symptôme ou le handicap entraîne une détresse ou une altération clinique significative dans le domaine du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants, ou nécessite une évaluation médicale.

Note de codage : Le code de la CIM-9-MC pour le trouble de conversion est **300.11** et est assigné indépendamment du type de symptôme. Le code de la CIM-10-MC dépend du type de symptôme (cf. ci-dessous).

Spécifier le type de symptôme :

(F44.4) Avec faiblesse ou paralysie

(F44.4) Avec mouvements anormaux (p. ex. tremblements, mouvements dystoniques, myoclonie, trouble de la marche)

(F44.4) Avec des symptômes de déglutition

(F44.4) Avec des troubles de l'élocution (p. ex. dysphonie, trouble de l'articulation)

(F44.5) Avec attaques ou crises épileptiformes

(F44.6) Avec anesthésie ou perte sensorielle

(F44.6) Avec symptôme sensoriel spécifique (p. ex. perturbations visuelles, olfactives ou auditives)

(F44.7) Avec symptômes associés

Spécifier si :

Épisode aigu : symptômes présents depuis moins de 6 mois.

Persistant : symptômes survenant depuis 6 mois ou plus.

Spécifier si :

Avec facteur de stress psychologique (*spécifier le facteur de stress*)

Sans facteur de stress psychologique

Caractéristiques diagnostiques

De nombreux cliniciens utilisent alternativement le qualificatif de « fonctionnel » (en référence à un fonctionnement du système nerveux central) ou « psychogène » (en référence à une étiologie possible) pour décrire les symptômes du trouble de conversion (trouble à symptomatologie neurologique fonctionnelle) (Stone et al. 2011). Dans le trouble de conversion, il peut exister un ou plusieurs symptômes de types variés. Les symptômes moteurs comprennent parésie ou paralysie, mouvements anormaux tels que tremblements ou mouvements dystoniques, anomalies de la marche et anomalies posturales des membres. Les symptômes sensoriels comprennent des sensations cutanées, visuelles ou auditives altérées, réduites ou absentes. Des épisodes de tremblements généralisés anormaux des membres s'accompagnant apparemment d'altération ou de perte de la conscience peuvent ressembler à des crises d'épilepsie (encore appelées *crises psychogènes ou non épileptiques*). Des épisodes d'inconscience ressemblant à des syncopes ou au coma peuvent être présents. D'autres symptômes comprennent une réduction de volume ou une absence de la parole (dysphonie/aphonie), des troubles de l'articulation (dysarthrie), une sensation de boule dans la gorge (globus) et de la diplopie.

Bien que le diagnostic requière que les symptômes ne soient pas explicables par une maladie neurologique, il ne doit pas être fait simplement au vu d'explorations normales ou parce que les symptômes sont « bizarres ». Il doit reposer sur des données cliniques qui prouvent clairement l'incompatibilité avec une maladie neurologique. L'absence de consistance avec les données de l'examen est une des manières de démontrer cette incompatibilité (c.-à-d. de démontrer que les signes physiques mis en évidence par une méthode d'examen ne sont plus positifs lorsqu'ils sont recherchés de façon différente). Des exemples de telles découvertes d'examen incluent :

- le signe de Hoover dans lequel une faiblesse d'extension de la hanche n'est plus observée lorsqu'il est demandé de réaliser une flexion de la hanche controlatérale contre résistance (Stone et al. 2010) ;
- un déficit marqué de flexion plantaire de la cheville observé sur la table d'examen chez un patient apte à marcher normalement sur la pointe des pieds ;
- des résultats positifs au test d'influencabilité du tremblement. Lors de ce test, un tremblement unilatéral peut être considéré comme fonctionnel s'il se modifie lorsque l'attention du patient est distraite de ce tremblement. Ceci peut être observé en demandant à la personne d'imiter l'examineur en réalisant un mouvement

rythmique avec la main indemne, ce qui induit une modification du tremblement fonctionnel qui va copier ou adopter le rythme de la main indemne, disparaître, ou perdre son mouvement rythmique (Edwards et Bhatia 2012) ;

- lors des attaques pouvant simuler une épilepsie ou une syncope (attaques non épileptiques « psychogènes »), la présence d'une résistance à l'ouverture des yeux clos (Avbersek et Sisodiya 2010) ou l'enregistrement d'un tracé électroencéphalographique normal (même si ce dernier élément seul ne permet pas d'éliminer toutes les étiologies d'épilepsie ou de syncope) ;
- lors de symptômes visuels, un champ visuel tubulaire (vision en tunnel) (Chen et al. 2007).

Il est important de noter que le diagnostic de trouble de conversion doit être fondé sur une évaluation clinique globale et non sur une manifestation clinique isolée.

Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

Plusieurs caractéristiques associées permettent de confirmer le diagnostic de trouble de conversion. Il peut exister des antécédents multiples de symptômes somatiques similaires. Le début des troubles peut être associé avec un stress ou un traumatisme de nature psychologique ou physique. La valeur étiologique potentielle de ce stress ou de ce traumatisme peut être suggérée par leur coïncidence temporelle étroite. Cependant, bien que l'existence d'un stress ou d'un traumatisme soit importante, le diagnostic ne doit pas être éliminé en leur absence (Stone et al. 2011).

Le trouble de conversion est souvent associé avec des symptômes dissociatifs tels que la dépersonnalisation, la déréalisation et l'amnésie dissociative, notamment au début des symptômes ou durant les attaques.

Le diagnostic de trouble de conversion ne nécessite pas que les symptômes soient jugés comme non intentionnels (c.-à-d. simulés) car l'absence de simulation n'est pas démontrable de façon fiable. Le phénomène de *la belle indifférence* (c.-à-d. l'absence d'intérêt concernant la nature ou les conséquences des symptômes) a été associé au trouble de conversion mais n'en est pas spécifique et ne doit pas être utilisé pour faire le diagnostic. De la même façon, le concept de *bénéfices secondaires* (c.-à-d. quand le sujet profite de bénéfices extérieurs tels que monétaires ou dus à la libération de ses responsabilités) n'est pas non plus spécifique du trouble de conversion et en particulier dans le contexte d'une preuve évidente de simulation, le diagnostic à évoquer est celui de troubles factices ou de simulation (cf. « Diagnostic différentiel » de ce trouble).

Prévalence

Des symptômes de conversion transitoires sont fréquents mais la prévalence exacte du trouble est inconnue. Cela est dû en partie au fait que le diagnostic requiert habituellement une évaluation en centre spécialisé où il serait présent chez environ 5 % des patients référés en neurologie. L'incidence de symptômes persistants de conversion est estimée entre 2 et 5/100 000 par an (Reuber 2008 ; Stone et al. 2010).

Développement et évolution

Le début des troubles peut survenir tout au long de la vie. Le début des attaques non épileptiques atteint son pic au cours de la 3^e décennie alors que les symptômes moteurs atteignent le leur au cours de la 4^e décennie. Les symptômes peuvent être transitoires ou persistants. Le pronostic est probablement meilleur chez les enfants que chez les adolescents et chez les adultes (Pehlivanürk et Unal 2002).